

Mioma uterino · sangramento e cirurgia

Leiomioma é causa comum de sangramento uterino anormal e massa pélvica. Conduta segue sintomas, desejo reprodutivo e localização (submucoso sangra mais).

Localização

Lembre - Localização

Submucoso (FIGO 0–2): sangramento. Intramural: volume/SUA. Subseroso: compressão. Pediculado pode torcer (abdome agudo).

Assintomático observa; SUA trata clinicamente; falha ou compressão caminha para procedimento.

Mioma por sintoma

Assintomático / SUA / compressivo

Assintomático

Achado de exame/USG
Observação
Seguir crescimento

Conservador

SUA / anemia

AINE, antifibrinolítico
Hormônio / DIU-LNG
Anemia: ferro

Clinico 1o

Cirúrgico

Submucoso: histeroscopia
Miomectomia se fertilidade
Histerectomia definitiva

Falha / desejo

Pontos de prova

- USG pélvico é 1ª imagem; RNM se mapeamento cirúrgico complexo
- DIU-LNG e agonistas de GnRH reduzem sangramento (GnRH temporário)
- Embolização: opção em selecionadas sem desejo imediato de gestar
- Crescimento rápido na pós-menopausa: excluir sarcoma (raro, mas cai)

Procedimento × objetivo

Objetivo | Opção

Preservar útero/fertilidade | Miomectomia
Submucoso sangrante | Histeroscopia resectoscópica
Definitivo sem fertilidade | Histerectomia
Má candidato cirúrgico | Embolização / clínico

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

SUA em >45 anos ou com critérios de risco: excluir hiperplasia/câncer de endométrio antes de atribuir tudo a mioma.